

دستورالعمل رسمی – سرخک (Measles)

رسمی و به‌روز وزارت بهداشت نیست. پیش از استفاده عملیاتی، محتوای این بخش باید با نسخه‌ی رسمی جایگزین شود. این سند صرفاً یک نمونه‌ی آزمایشی برای تست نمایش فایل PDF داخل مینی‌آپ است و جایگزین دستورالعمل

۱. اقدامات فوری در مواجهه با مورد مشکوک

- و حداقل یکی از علائم سرفه، آبریزش بینی یا التهاب ملتحمه)، اقدامات زیر باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود:
- به‌محض شناسایی هر فرد واجد تعریف مورد مشکوک سرخک (تب همراه با بثورات ماکولوپاپولار
 - ایزوله کردن بیمار از سایر مراجعان، ترجیحاً در اتاق جداگانه با تهویه مناسب
 - تکمیل فرم گزارش مورد مشکوک و ارسال فوری (کمتر از ۲۴ ساعت) به کارشناس مراقبت بیماری‌های شبکه
 - نمونه‌گیری خون جهت بررسی IgM و در صورت امکان نمونه ادرار/حلق برای PCR
 - ثبت وضعیت واکسیناسیون بیمار و تاریخ آخرین دوز دریافتی
 - شروع بررسی مقدماتی منبع مواجهه و تماس‌های اخیر بیمار

۲. نظام گزارش‌دهی

- سرخک جزو بیماری‌های مشمول گزارش‌دهی فوری است. مسیر گزارش‌دهی به‌ترتیب زیر دنبال می‌شود:
- گزارش مورد مشکوک: در همان روز شناسایی، از طریق فرم استاندارد
 - گزارش نتیجه آزمایشگاهی: حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت جواب
 - ثبت نهایی در سامانه مراقبت بیماری‌های واگیر توسط کارشناس بهداشت مسئول

۳. ردیابی و پیگیری تماس‌ها

- شناسایی تمامی تماس‌های نزدیک طی دوره واگیری بیمار (۴ روز قبل تا ۴ روز بعد از بثورات)
- بررسی وضعیت واکسیناسیون تماس‌ها و ارجاع افراد فاقد ایمنی برای واکسیناسیون اورژانسی طی ۷۲ ساعت
- پیگیری تماس‌های پرخطر (نوزادان، بارداران، افراد دارای نقص ایمنی) به‌صورت روزانه تا پایان دوره کمون

۴. اقدامات کنترل طغیان

- در صورت شناسایی بیش از یک مورد مرتبط اپیدمیولوژیک، تشکیل تیم پاسخ سریع در سطح شبکه بهداشت
- ارزیابی پوشش واکسیناسیون منطقه و اجرای واکسیناسیون تکمیلی در صورت نیاز
- اطلاع‌رسانی به مراکز درمانی منطقه جهت افزایش هوشیاری تشخیصی